

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 11- MÓDULO 4: Farmacología de Sistemas: Respiratorio, piel, ojo y

oído	4
1. Introducción y objetivos	4
2. Farmacología respiratoria	4
Broncodilatadores.....	5
Corticoides	7
Antihistamínicos H1	8
Oxígeno como gas terapéutico	9
Manejo de la tos y secreciones	9
Antitusivos (solo para tos seca)	11
Resumen respiratorio en 10 puntos	12
3. Farmacología de la piel (Dermatología)	12
Control del prurito.....	13
♦ a. Antihistamínicos H1.....	13
♦ b. Corticoides.....	13
♦ c. Oclacitinib	14
♦ d. Lokivetmab	14
♦ e. Ciclosporina.....	14
Control de inflamación cutánea	15
♦ Tacrolimus	15
Control de infecciones secundarias	15
Restauración de barrera cutánea.....	16
4. Farmacología oftalmológica (ojo).....	16
Fármacos que disminuyen la presión intraocular.....	17
a. Inhibidores de producción de humor acuoso	17
b. Fármacos que aumentan drenaje	18
Fármacos que modifican el diámetro pupilar	18
Inmunomoduladores tópicos	19
Antiinflamatorios oftálmicos	20
Antibióticos tópicos	21
Conceptos farmacológicos clave	21
5. Farmacología del oído (otológica)	21
Ceruminolíticos y limpiadores	22
Antibióticos tópicos	23

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Antimicóticos tópicos	24
Corticoides tópicos.....	25
Tratamiento sistémico (cuando está indicado)	25
Formulaciones combinadas	25
6. Actividades de autoevaluación	25
 7. Resumen en 10 puntos	26
 8. Errores clínicos frecuentes	27
 9. Checklist de examen	27
 10. Bibliografía recomendada.....	27

SEMANA 11- MÓDULO 4: Farmacología de Sistemas: Respiratorio, piel, ojo y oído

1. Introducción y objetivos

En esta semana abordamos patologías que afectan directamente la calidad de vida del paciente:

-  Disnea
-  Prurito
-  Dolor ocular
-  Otitis

En dermatología, la farmacología ha evolucionado notablemente en la última década, desplazando el uso crónico de corticoides hacia terapias dirigidas como inhibidores de JAK (Oclacitinib) y anticuerpos monoclonales (Lokivetmab).

En oftalmología, el ojo funciona como un órgano “santuario”, con barreras anatómicas que limitan la penetración farmacológica. Un error terapéutico puede comprometer la visión en pocas horas.

Objetivos de la semana

1. Diferenciar tos productiva de tos seca y elegir tratamiento adecuado.
2. Comprender el uso racional de broncodilatadores.
3. Entender la inmunomodulación moderna en dermatitis atópica.
4. Manejar farmacológicamente glaucoma y ojo seco.
5. Reconocer la contraindicación absoluta de corticoides en úlcera corneal.
6. Comprender la estrategia integral en otitis externas.

2. Farmacología respiratoria

Objetivos terapéuticos

- Mejorar ventilación
- Disminuir broncoconstricción
- Optimizar intercambio gaseoso
- Manejar secreciones
- Controlar la tos cuando sea necesario

Enfoque clínico inicial

Antes de medicar, diferenciar:

♦ Enfermedad obstructiva alta

Ejemplos:

- Colapso traqueal
- Edema laríngeo
- Parálisis laríngea

Signos:

- Estridor inspiratorio
 - Tos seca, “de ganso”
 - Aumento del esfuerzo inspiratorio
-

♦ Enfermedad obstructiva baja

Ejemplos:

- Asma felino
- Bronquitis crónica
- RAO equino

Signos:

- Espiración prolongada
- Sibilancias
- Patrón espiratorio forzado

👉 Esta diferenciación define el tratamiento.

Broncodilatadores

Indicados en broncoconstricción (obstrucción baja).

◊ a. *Agonistas β_2 adrenérgicos*

Salbutamol

- Vía: Inhalatoria (aerocámara)
- Acción rápida (rescate)
- Duración corta

Mecanismo:

Estimula receptor $\beta_2 \rightarrow \uparrow \text{AMPc} \rightarrow$ relajación del músculo liso bronquial.

Indicación:

Crisis asmática felina.

Clenbuterol

- Vía: Oral / IV
- Más prolongado
- Muy usado en equinos

Efecto

adicional:

Mejora aclaramiento mucociliar.

♦ Adrenalina (epinefrina)

No es broncodilatador crónico.

Mecanismo:

- $\beta_2 \rightarrow$ broncodilatación
- $\alpha_1 \rightarrow$ vasoconstricción mucosa ($\downarrow$ edema)

Indicaciones:

- Anafilaxia
- Edema laríngeo
- Emergencia obstructiva alta

Uso:

IM o nebulizada en emergencias.

♦ b. Anticolinérgicos

Ipratropio

Grupo:

Antagonista muscarínico (M3)

Mecanismo:

Bloquea broncoconstricción vagal.

Vía:

Inhalatoria.

Uso:

- Asma felino
- Bronquitis crónica

- Terapia combinada con β_2

Ventaja:

Actúa por vía diferente → efecto aditivo.

◊ c. Metilxantinas

Teofilina / Aminofilina

Mecanismo:

- Inhiben fosfodiesterasa → ↑ AMPc
- Antagonizan adenosina
- Estimulan centro respiratorio

Vía:

Oral / IV lenta

Precaución:

Margen terapéutico

estrecho.

Taquicardia, excitación.

Uso actual más limitado.

Corticoides

(No broncodilatan directamente)

El asma es inflamatorio, no solo broncospástico.

Corticoides sistémicos

Indicados en:

- Asma felino
- Bronquitis inflamatoria
- Crisis moderada-grave

Disminuyen:

- Edema
- Infiltrado eosinofílico
- Hiperreactividad bronquial

◆ Corticoides inhalados en asma felino

Fluticasona (inhalatoria)

Mecanismo:

Glucocorticoide tópico potente → inhibe inflamación bronquial.

Ventaja:

- Actúa localmente
- Mínimos efectos sistémicos
- Uso crónico seguro

Estrategia moderna:

Fluticasona (control crónico)

Salbutamol (rescate)

Representa el estándar actual en asma felino.

Antihistamínicos H1

(No son broncodilatadores directos)

La histamina participa en broncoconstricción y edema, pero no es el único mediador en asma crónico.

♦ Primera generación

- Difenhidramina
- Clorfeniramina

Características:

- Sedantes
 - Anticolinérgicos
 - Cruzan BHE
-

♦ Segunda generación

- Loratadina
- Cetirizina

Características:

- Más selectivos periféricos
 - Menos sedación
-

Uso clínico:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Útiles en:

- Reacciones alérgicas agudas
- Broncoespasmo mediado por histamina

Limitados en:

- Asma crónico
- Bronquitis inflamatoria persistente

Oxígeno como gas terapéutico

El oxígeno es un fármaco.

Indicaciones:

- Hipoxemia
- Edema pulmonar
- Crisis asmática
- Neumonía grave
- Shock

Vías:

- Cámara
- Catéter nasal
- Mascarilla
- Jaula enriquecida

Concepto

No trata la

Mantiene oxigenación mientras se corrige el problema.

clave:

causa.

Riesgo:

Toxicidad por O₂ a concentraciones altas prolongadas.

Manejo de la tos y secreciones

La tos es un reflejo protector.

♦ Tos Productiva (NO suprimir)

Acetilcisteína

Es mucolítico.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Rompe puentes disulfuro → ↓ viscosidad.

Vía:

Nebulización.

Bromhexina

Es mucolítico y expectorante.

↑ secreción acuosa.

Mejora penetración antibiótica.

Guayfenesina (Éter gliceril guayacolato)

Es expectorante.

Mecanismo:

Estimula secreción traqueobronquial → fluidifica moco.

Uso:

- Expectorante clásico
- Más relevante en equinos
- En pequeños animales hoy poco usado

Nota:

En equinos es más conocido como relajante muscular en anestesia.

Fármaco	Grupo farmacológico	Mecanismo principal	Efecto sobre el moco	Vía habitual	Comentarios clínicos
Acetilcisteína	Mucolítico químico	Rompe puentes disulfuro de las mucoproteínas	Disminuye fuertemente la viscosidad	Nebulización	Muy potente. Puede irritar vía aérea. También es antídoto de paracetamol y antioxidante.
Bromhexina	Mucolítico–secretolítico	Despolimeriza mucopolisacáridos + secreción serosa	↓ viscosidad + estimula componente acuoso	↑ Oral	Mejora transporte mucociliar. Más “fisiológica” que acetilcisteína.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Fármaco	Grupo farmacológico	Mecanismo principal	Efecto sobre el moco	Vía habitual	Comentarios clínicos
Guayfenesina (Éter gliceril guayacolato)	Expectorante	Estimula secreción traqueobronquial refleja	Aumenta volumen de secreción, la fluidifica	Oral (expectorante)	Uso limitado en pequeños animales. En equinos se usa más como relajante muscular central en anestesia.

Antitusivos (solo para tos seca)

Codeína / Hidrocodona

Opioides.

Depresión del centro bulbar de la tos.

Uso:

Colapso traqueal

Traqueobronquitis irritativa

Butorfanol

Opioide agonista-antagonista.

Antitusivo inyectable potente.

Rol de Maropitant en Tos

Maropitant:

Antagonista NK-1 (sustancia P).

Aunque es antiemético, la sustancia P participa en el reflejo tusígeno.

Uso:

Puede reducir tos asociada a irritación traqueal crónica.

No es antitusivo clásico.

Se considera opción complementaria en colapso traqueal.

Crisis asmática vs colapso traqueal

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Característica	Crisis Asmática (Baja)	Colapso Traqueal (Alta)
Tipo de obstrucción	Bronquial distal	Traqueal proximal
Sonido	Sibilancias	Tos “de ganso”
Fase afectada	Espiración prolongada	Inspiración (frecuente)
Tratamiento principal	Broncodilatadores + corticoides	Antitusivos + control peso
Uso de β_2	Sí	No es clave
Oxígeno	Frecuente	En crisis grave
Antitusivos	No	Sí

Resumen respiratorio en 10 puntos

- Diferenciar obstrucción alta vs baja es clave terapéutica.
- El asma felino es inflamatorio + broncospástico.
- Salbutamol es fármaco de rescate.
- Fluticasona es control crónico en asma felino.
- Ipratropio bloquea tono vagal bronquial.
- Teofilina tiene margen estrecho.
- No suprimir tos productiva.
- Opioides son antitusivos centrales.
- El oxígeno es un fármaco, no un complemento.
- La adrenalina es para emergencia, no mantenimiento.

3. Farmacología de la piel (Dermatología)

Objetivos terapéuticos

- Controlar inflamación
 - Disminuir prurito
 - Restaurar barrera cutánea
 - Controlar infección secundaria
 - Modular respuesta inmune
 - Eliminar agentes etiológicos (parásitos, hongos, bacterias)
-

Control del prurito

El prurito puede ser:

- Histaminérgico
- Mediado por IL-31
- Neuroinflamatorio
- Secundario a infección
- Autoinmune

♦ a. Antihistamínicos H1

No son los más potentes en perros.

Primera generación

- Difenhidramina
- Clorfeniramina

Cruzan BHE → sedación

Efecto anticolinérgico

Segunda generación

- Loratadina
- Cetirizina

Más selectivos periféricos

Menos sedantes

✦ Funcionan mejor en:

- Urticaria aguda
- Reacciones alérgicas inmediatas

Limitados en:

- Dermatitis atópica crónica

♦ b. Corticoides

Prednisolona / Dexametasona

Potentes antipruriginosos.

Mecanismo:

- Inhiben fosfolipasa A2
- ↓ prostaglandinas y leucotrienos

- ↓ citocinas inflamatorias

Uso:

- Crisis aguda
- Dermatitis alérgica severa
- Enfermedades autoinmunes

△ Efectos adversos:

- PU/PD
 - Inmunosupresión
 - Atrofia cutánea crónica
-

◇ c. Oclacitinib

Inhibidor JAK1.

Bloquea señalización de IL-31 (principal citocina del prurito).

Inicio rápido (horas).

Uso:

- Dermatitis atópica
- Prurito alérgico

Ventaja:

No es corticoide.

Menos efectos sistémicos.

◇ d. Lokivetmab

Anticuerpo monoclonal anti-IL-31.

Uso:

- Dermatitis atópica canina

Ventaja:

- Muy específico
 - Aplicación mensual
 - Mínimos efectos sistémicos
-

◇ e. Ciclosporina

Inhibe calcineurina → ↓ activación linfocitos T.

Uso:

- Dermatitis atópica crónica
- Enfermedades inmunomediadas

Inicio lento (3–4 semanas).

Control de inflamación cutánea

Incluye:

- Corticoides sistémicos
 - Corticoides tópicos
 - Tacrolimus tópico
-

◊ Tacrolimus

Inhibidor calcineurina tópico.

Uso:

- Lupus discoide
 - Dermatitis localizada
 - Alternativa a corticoides crónicos
-

Control de infecciones secundarias

Muy frecuentes en dermatitis alérgica.

◆ Piodermas bacterianas

Principal agente:

Staphylococcus pseudintermedius.

Tratamiento:

Sistémico:

- Cefalexina
- Amoxicilina-clavulánico
- Clindamicina

Tópico:

- Clorhexidina

- ✦ Siempre tratar mínimo 7–14 días después de resolución clínica.
-

◆ Dermatitis por Malassezia

Tratamiento:

- Ketoconazol
 - Itraconazol
 - Champús con miconazol
-

Restauración de barrera cutánea

Concepto moderno clave en atopía.

Incluye:

- Ácidos grasos esenciales ($\omega 3$, $\omega 6$)
- Emolientes tópicos
- Champús humectantes
- Ceramidas

No reemplazan antiinflamatorios, pero reducen recaídas.

◆ RESUMEN EN 10 PUNTOS

- El prurito no siempre es histamínico.
 - IL-31 es clave en dermatitis atópica.
 - Corticoides son los más potentes, pero no siempre los más seguros.
 - Oclacitinib actúa rápido.
 - Lokivetmab es altamente específico.
 - Infección secundaria perpetúa prurito.
 - No tratar pioderma es fracasar terapéuticamente.
 - Isoxazolinas revolucionaron el manejo de sarnas.
 - Barrera cutánea es parte del tratamiento, no cosmética.
 - Dermatología es manejo crónico, no solución instantánea.
-

4. Farmacología oftalmológica (ojo)

Particularidades farmacocinéticas del ojo

El ojo presenta barreras que condicionan la farmacología:

- Epitelio corneal (lipofílico)
- Barrera hemato-acuosa
- Barrera hemato-retiniana
- Lavado lagrimal constante

 Implicancia farmacológica:

- La vía tópica es la principal.
- La absorción sistémica puede ocurrir vía conducto nasolagrimal.
- La integridad epitelial modifica penetración (una úlcera aumenta absorción).

Objetivos farmacológicos en oftalmología

- Disminuir presión intraocular
- Modificar diámetro pupilar
- Controlar inflamación
- Modular respuesta inmune local
- Prevenir infección secundaria
- Controlar dolor ocular

Fármacos que disminuyen la presión intraocular

a. Inhibidores de producción de humor acuoso

◊ *Inhibidores de Anhidrasa Carbónica (tópicos)*

Dorzolamida

Mecanismo:

Inhibe anhidrasa carbónica en procesos ciliares → ↓ formación de bicarbonato → ↓ secreción de humor acuoso.

Ventaja:

Menos efectos sistémicos que los inhibidores orales.

Uso clínico:

Glaucoma (especialmente en gatos).

◊ *Beta-bloqueantes*

Timolol

Mecanismo:

Bloquea receptores β en cuerpo ciliar $\rightarrow$ $\downarrow$ producción de humor acuoso.

Advertencia:

Puede absorberse sistémicamente $\rightarrow$ bradicardia, hipotensión.

b. Fármacos que aumentan drenaje

◊ Análogos de Prostaglandina F2 α

Latanoprost

Mecanismo:

Aumenta drenaje por vía uveoescleral + induce miosis intensa.

Uso clínico:

Muy eficaz en urgencias en perros.

Eficacia limitada en gatos.

◊ Parasimpaticomiméticos

Pilocarpina

Mecanismo:

Agonista muscarínico $\rightarrow$ contracción esfínter del iris $\rightarrow$ miosis $\rightarrow$ apertura mecánica del ángulo iridocorneal.

Hoy menos usada que prostaglandinas.

Fármacos que modifican el diámetro pupilar

◊ Midriáticos / Cicloplejicos

Atropina

Antagonista muscarínico potente y de acción prolongada.

Efectos:

- Midriasis intensa
- Cicloplejia marcada y prolongada

Duración:

- Midriasis: varios días
- Cicloplejia: 24–72 h o más

Aplicación farmacológica:

- Disminuye dolor por espasmo del cuerpo ciliar
- Útil en inflamación intraocular (uveítis)
- Previene sinequias posteriores

Precaución:

- Puede aumentar presión intraocular
 - Contraindicada en glaucoma
-

Tropicamida

Antagonista muscarínico de acción corta.

Efectos:

- Midriasis rápida
- Cicloplejia leve y breve

Duración:

- 4–8 horas (mucho más corta que atropina)

Aplicación farmacológica:

- Exploración diagnóstica del fondo de ojo
- Dilatación pupilar transitoria

Ventaja sobre atropina:

- Recuperación más rápida
- Menor duración de alteración visual

Limitación:

- No es adecuada para control de dolor en inflamación intraocular (cicloplejia insuficiente).
-

♦ Mióticos

Pilocarpina (ya mencionada)

Uso limitado actual.

Inmunomoduladores tópicos

Actúan sobre inflamación crónica mediada por linfocitos T.

Ciclosporina A

Tacrolimus

Mecanismo:

Inhibición de calcineurina → ↓ activación linfocitaria → ↓ citocinas.

Aplicación clínica:

Queratoconjuntivitis seca autoinmune.

Importante:

Uso crónico.

Efecto progresivo.

Antiinflamatorios oftálmicos

◊ *Corticoides tópicos*

Ejemplos:

- Dexametasona
- Betametasona

Mecanismo:

Inhibición fosfolipasa A2 → ↓ mediadores inflamatorios.

Indicaciones:

Inflamación ocular sin lesión corneal.

⚠ Contraindicación farmacológica crítica:

Si hay defecto epitelial corneal:

Los corticoides:

- Inhiben cicatrización
- Aumentan colagenasas
- Favorecen perforación

Regla farmacológica:

Siempre test de fluoresceína antes de indicar corticoide.

◊ *AINEs oftálmicos*

Menor potencia que corticoides.

Útiles en inflamación leve o postquirúrgica.

Antibióticos tópicos

Indicados ante alteración de barrera corneal.

Opciones:

- Tobramicina
- Ciprofloxacina
- Cloranfenicol (excelente penetración)

Principio farmacológico:

Prevención de colonización bacteriana secundaria.

Conceptos farmacológicos clave

- La mayoría de fármacos oftálmicos son tópicos.
 - La absorción sistémica es posible.
 - El estado del epitelio corneal modifica la farmacocinética.
 - Disminuir PIO implica ↓ producción o ↑ drenaje.
 - Midriasis y miosis tienen implicancias terapéuticas opuestas.
 - Los corticoides están contraindicados ante lesión epitelial.
 - Los inmunomoduladores actúan sobre base inmunológica crónica.
-

5. Farmacología del oído (otológica)

PARTICULARIDADES FARMACOLÓGICAS DEL OÍDO EXTERNO

El conducto auditivo externo:

- Es húmedo y cerrado
- Tiene epitelio queratinizado
- Produce cerumen (mezcla lipídica + descamación)
- Tiene pH levemente ácido

Factores que afectan la farmacología:

- Presencia de pus o cerumen (inactiva antibióticos)
- Integridad del tímpano
- Estenosis o hiperplasia crónica

- Biofilm bacteriano

👉 La vía tópica es la regla en otitis externa.

OBJETIVOS FARMACOLÓGICOS

- Remover detritos y cerumen
- Restaurar pH fisiológico
- Controlar infección bacteriana
- Controlar infección fúngica
- Disminuir inflamación y dolor
- Evitar daño ototóxico

Ceruminolíticos y limpiadores

Primera etapa obligatoria.

El cerumen y el exudado:

- Inactivan antibióticos
- Disminuyen penetración
- Favorecen biofilm

◆ Ácido Salicílico

- Ceruminolítico
- Queratorregulador
- Leve efecto antiinflamatorio

◆ Ácido Láctico

- Acidificante
- Inhibe crecimiento bacteriano

◆ Propilenglicol

- Solvente
- Mejora penetración
- Humectante

Importancia del pH

Muchas bacterias patógenas (ej. Pseudomonas) proliferan mejor en pH neutro-alcalino.

La acidificación:

- ✓ Disminuye crecimiento bacteriano
- ✓ Mejora eficacia antibiótica

Concepto crítico: ototoxicidad

Si el tímpano está perforado, ciertos fármacos pueden alcanzar oído medio/interno.

Pueden dañar:

- Células ciliadas cocleares
- Nervio vestibulococlear

Consecuencias:

- Sordera
- Ataxia
- Nistagmo

Fármacos potencialmente ototóxicos

- Aminoglucósidos (Gentamicina, Neomicina)
- Clorhexidina concentrada
- Alcohol

👉 Siempre evaluar integridad timpánica antes de usar.

Antibióticos tópicos

Indicados ante infección bacteriana.

Principales agentes en otitis externa:

- Staphylococcus pseudintermedius
- Pseudomonas aeruginosa

♦ Gentamicina (Aminoglucósido)

Mecanismo:

Inhibe síntesis proteica (30S).

Eficaz contra:

Gram negativos y algunos Gram positivos.

Precaución:

Ototóxica si tímpano roto.

♦ Enrofloxacin

Fluoroquinolona.

Mecanismo:

Inhibe ADN girasa.

Ventaja:

Activa contra *Pseudomonas*.

♦ Polimixina B

Actúa sobre membrana bacteriana (Gram negativos).

Frecuente en combinaciones.

Antimicóticos tópicos

Frecuentes en otitis por *Malassezia pachydermatis*.

♦ Clotrimazol

♦ Miconazol

Azoles.

Mecanismo:

Inhiben síntesis de ergosterol en membrana fúngica.

♦ Nistatina

Se une a ergosterol → altera permeabilidad.

Uso frecuente en combinaciones.

Corticoides tópicos

Componentes clave en gotas compuestas.

Ejemplos:

- Dexametasona
 - Betametasona
 - Mometasona
-

Objetivos farmacológicos

- ↓ Edema
- ↓ Prurito
- ↓ Dolor
- ↓ Hiperplasia epitelial

Ventaja:

Mejoran penetración antibiótica al reducir inflamación.

Tratamiento sistémico (cuando está indicado)

No toda otitis externa requiere antibiótico sistémico.

Indicaciones:

- Otitis media
 - Celulitis peri-auricular
 - Fiebre
 - Fracaso de terapia tópica
-

Formulaciones combinadas

La mayoría de los preparados comerciales contienen:

- ✓ Antibiótico
- ✓ Antimicótico
- ✓ Corticoide

Estrategia lógica para otitis mixtas.

6. Actividades de autoevaluación

Caso 1: El Perro que Tose

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Un Caniche geronte tiene tos seca, "de ganso", fuerte, cada vez que se excita.
Diagnóstico: Colapso Traqueal. No hay infección.

1. ¿Indicaría un mucolítico o un antitusivo?
2. Si elige **Codeína** o **Butorfanol**, ¿cuál es el mecanismo por el cual el perro deja de toser?

Caso 2: El Gato que se rasca

Un gato tiene lesiones en el cuello por rascado intenso. Diagnóstico: Dermatitis Atópica Felina.

1. Usted sabe que los gatos resisten bien los corticoides, pero el dueño quiere algo más moderno y seguro a largo plazo. ¿Qué opción inmunomoduladora oral (líquida) o sistémica podría ofrecerle?
2. ¿Por qué los antihistamínicos suelen fracasar en este caso?

Caso 3: Ojo Rojo

Llega un perro con el ojo cerrado, dolor y córnea azulada (edema).

1. El dueño tiene en casa un colirio de "Dexametasona con Neomicina". Le pregunta si puede ponérselo.
2. ¿Qué prueba diagnóstica **obligatoria** debe hacer usted antes de responderle? Justifique.

Caso 4: Otitis Purulenta

Un Cocker tiene el oído lleno de pus.

1. ¿Por qué aplicar las gotas antibióticas directamente sobre el pus es un desperdicio de dinero?
2. ¿Qué paso previo es fundamental para el éxito del tratamiento?

7. Resumen en 10 puntos

- Los fármacos respiratorios incluyen antitusivos, mucolíticos y broncodilatadores.
- Es fundamental diferenciar tos seca de tos productiva antes de tratar.
- Los antihistamínicos tienen eficacia variable en dermatología canina.
- Los glucocorticoides siguen siendo pilares en alergias moderadas.
- Apoquel y Cytopoint revolucionaron el tratamiento del prurito.
- Los otológicos combinados deben usarse con diagnóstico preciso.
- En oftalmología, nunca usar corticoides en úlcera corneal.
- Las infecciones mixtas requieren terapias integradas.
- El uso racional evita resistencia y complicaciones.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- El examen físico orienta todo el tratamiento farmacológico.

8. Errores clínicos frecuentes

- Tratar tos productiva con antitusivos.
- Usar corticoides tópicos en úlcera corneal.
- Aplicar otológicos sin examinar el tímpano.
- Confundir alergia ambiental con alimentaria.
- No considerar efectos secundarios sistémicos.
- Usar broncodilatadores sin causa broncoconstrictiva.
- Combinar demasiados productos tópicos sin criterio.
- No revisar progresos en otitis crónicas.
- Usar antihistamínicos como monoterapia en alergias severas.
- Saltarse la citología en lesiones dérmicas.

9. Checklist de examen

- ¿Diferencio tos seca de productiva?
- ¿Comprendo riesgo de corticoides en úlcera corneal?
- ¿Sé elegir broncodilatador adecuado?
- ¿Conozco diferencias entre Oclacitinib y Lokivetmab?
- ¿Sé cuándo usar mucolíticos?
- ¿Conozco protocolos básicos respiratorios?
- ¿Comprendo riesgos por abuso de corticoides?

10. Bibliografía recomendada

- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs.
- Miller & Griffin. Muller & Kirk's Small Animal Dermatology.
- King LG. Respiratory Pharmacology in Small Animals.
- Gelatt KN. Veterinary Ophthalmology.
- Riviere & Papich. Veterinary Pharmacology and Therapeutics.